Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
1ª Vara Cível da Comarca de Serra Talhada

R CABO JOAQUIM DA MATA, S/N, Forum Dr. Clodoaldo Bezerra de Souza e Silva, TANCREDO NEVES, SERRA TALHADA - PE - CEP: 56909-115 - F:(87) 39293586

Processo nº 0006001-91.2024.8.17.3370

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO

S E N T E N Ç A

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO** ajuizou a presente ação civil pública contra o **ESTADO DE PERNAMBUCO**, alegando, em suma, que WESLLAYNE MENDES FREIRE foi diagnosticado com *"Urticária Crônica Espontânea (UCE), classificada sob o CID 10: L50.8."*, e, por isso, necessita fazer uso do(s) medicamento(s) OMALIZUMABE. Ressalta que WESLLAYNE MENDES FREIRE e sua família não tem condições financeiras de arcar com os custos do tratamento. O *parquet* argumenta o ESTADO DE PERNAMBUCO não forneceu voluntariamente o(s) medicamento(s). O Ministério Público requereu o deferimento de tutela de urgência para que o ente público demandado forneça desde logo o(s) medicamento(s) ora pleiteados.

Com a petição inicial foram apresentados documentos.

No despacho de ID 190725618, determinou-se que fosse oficiado ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (e-NatJus), solicitando parecer técnico sobre o caso. Além disso, foi determinada a citação da parte adversa e a sua intimação para se manifestar a respeito do pedido antecipatório.

O Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (e-NatJus) apresentou nota técnica (ID 192093424). O pedido de tutela de urgência foi deferido (ID 192093423).

O ESTADO DE PERNAMBUCO apresentou contestação (ID 194658680).

É o breve relato. **Decido**.

Cumpre esclarecer que o feito comporta julgamento abreviado, nos termos do art. 355, I, do CPC, pois desnecessária a dilação probatória para a oferta da prestação jurisdicional.

Por oportuno, cabe esclarecer que *"Não é necessário o anúncio prévio do julgamento do pedido nas situações do art. 355 do CPC"* (Enunciado n° 27 da I Jornada de Direito Processual Civil realizado STJ/CJF).

Não há questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação.

Com isso, passo a enfrentar o mérito.

Sem maiores delongas, esclareço, desde logo, que o pedido formulado na exordial deve ser julgado **procedente**.

Explico.

A CRFB, em seu art. 6º, estabelece que:

> "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição".

Por sua vez, o art. 196 da Carta Magna define que:

> "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Conforme se depreende dos preceitos constitucionais suso transcritos, compete ao Poder Público garantir e assegurar o direito à saúde, que é indissociável do direito à vida, prerrogativa constitucional com caráter de direito fundamental, que não pode ser preterido por questões burocráticas, políticas, econômicas ou orçamentárias.

Neste passo, já afirmou o Ministro Marco Aurélio que *"o Estado deve assumir as funções que lhe são próprias, sendo certo, ainda, que problemas orçamentários não podem obstaculizar o implemento do que previsto constitucionalmente"*[1] (file:///D:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/Por%20mat%C3%A9ria/Fazenda%20P%C3%BAblica/Sa%C3%BAde/Senten%C3%A7a/Proced%C3%

No expressivo dizer de José Afonso da Silva, *"o sistema único de saúde, integrado de uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, constitui o meio pelo qual o Poder Público cumpre seu dever na relação jurídica de saúde que tem no pólo ativo qualquer pessoa e a comunidade, já que o direito à promoção e à proteção da saúde é também um direito coletivo. O sistema único de saúde implica ações e serviços federais, estaduais, distritais (DF) e municipais, regendo-se pelos princípios da descentralização, com direção única em cada esfera de governo, do atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, e da participação da comunidade, que confirma seu caráter de direito social pessoal, de um lado, e de direito social coletivo, de outro"*[2] (file:///D:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/Por%20mat%C3%A9ria/Fazenda%20P%C3%BAblica/Sa%C3%BAde/Senten%C3%A7a/Proced%C3%

Nessa esteira de raciocínio, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal: *"O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconseqüente. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado"*[3] (file:///D:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/Por%20mat%C3%A9ria/Fazenda%20P%C3%BAblica/Sa%C3%BAde/Senten%C3%A7a/Proced%C3%

Conclui-se, pois, que a garantia constitucional e/ou direito à saúde e os meios necessários para a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana não significam tão somente um "sonho" do legislador constituinte embebido em devaneio altruísta.

A moderna hermenêutica constitucional aponta para a máxima eficácia das normas, mesmo em se tratando de normas programáticas, sendo que no caso depara-se com normas imediatamente preceptivas, dado o grau imediato de comando e eficácia.

Assim, seja com base nos preceptivos constitucionais invocados, de eficácia não programática, mas auto-executáveis, seja com base na legislação infraconstitucional, o direito invocado está garantido na *Lex Mater*, e deve ser efetivado mediante a obrigação dos Municípios e do Estado em arcar com despesas referentes ao fornecimento de medicamentos e insumos, devidamente prescritos, aos cidadãos sujeitos a tratamento médico específico e, por conseguinte, garantirem o direito à vida.

Nesse passo, o fato de alguém necessitar de tratamento inadiável, aliado ao impostergável dever do Estado de assegurar a todos os cidadãos, especialmente os mais carentes, o direito à saúde, justifica a imposição ao ente público da obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso, fornecendo-lhes, sobretudo em casos como o figurado em tela, os meios necessários para garantir-lhes melhor qualidade de vida, diminuindo os sofrimentos de que padecem.

No caso *sub examine*, conforme os laudos médicos anexados, WESLLAYNE MENDES FREIRE ela sofre de *"Urticária Crônica Espontânea (UCE), classificada sob o CID 10: L50.8."* e precisa ser tratado(a) com o(s) medicamento(s) *"OMALIZUMABE"*.

Registro, por oportuno, que de acordo com as informações apresentadas pelo NatJus, *"OMALIZUMABE"* possui registro na ANVISA, a indicação do tratamento está em conformidade com a aprovada no registro, e, apesar de ser fornecido pelo SUS, **não o é** para a enfermidade que afeta WESLLAYNE MENDES FREIRE.

O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 566.471 (Tema nº 6), definiu os parâmetros a serem observados para a concessão judicial de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Na ocasião, foi editada a Súmula Vinculante nº 61, com a seguinte redação: *"A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)"*.

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:

"1. A **ausência de inclusão** de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) **impede**, como **regra geral**, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, **excepcionalmente**, a concessão judicial de medicamento **registrado na ANVISA**, mas **não incorporado** às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, **cumulativamente**, os seguintes requisitos, cujo **ônus probatório incumbe ao autor da ação**:

(a) **negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa**, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) **ilegalidade do ato de não incorporação** do medicamento pela Conitec, **ausência de pedido de incorporação** ou da **mora na sua apreciação**, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c) **impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS** e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da **medicina baseada em evidências**, da **eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco**, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente **ensaios clínicos randomizados** e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) **imprescindibilidade clínica do tratamento**, comprovada mediante **laudo médico fundamentado**, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. **Sob pena de nulidade da decisão judicial**, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, **deverá obrigatoriamente**:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, **não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo**;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, **não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação**; e

(c) **no caso de deferimento** judicial do fármaco, **oficiar** aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS."

O STF, na decisão proferida no RE 1.366.243 (Tema 1.234), estabeleceu a **definição** de medicamentos **não incorporados** como sendo *"aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico"*.

Desse modo, verifica-se que a situação em apreço envolve **medicamento não padronizado**.

Quanto a esse tema, o STJ fixou a seguinte tese no RESP 165715 (Tema 106):

"[...].

A concessão dos **medicamentos não incorporados** em atos normativos do SUS exige a presença **cumulativa** dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

[...]."

O STF, após fixar tese no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243), editou a Súmula Vinculante nº 60, com i seguinte teor: *"O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)"*.

Foi definido, entre outros, o seguinte:

"[...].

4) Sob pena de **nulidade** do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, **ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados**, deverá **obrigatoriamente** analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo **da não incorporação** pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário **não pode substituir** a vontade do administrador, mas tão somente **verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS**.

4.2) A **análise jurisdicional** do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado **restringe-se** ao exame da **regularidade do procedimento** e da **legalidade do ato de não incorporação** e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, **não sendo possível incursão no mérito administrativo**, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de **medicamento não incorporado**, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, **não basta a simples alegação de necessidade** do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a **demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível**, ou seja, **unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise**.

[...]."

Como se pode notar, somente é possível deferir o pleito de fornecimento de medicamento não padronizado se preenchidos **cumulativamente** todos os seguintes pressupostos:

1. existência de registro na ANVISA do medicamento;

2. incapacidade financeira do(a) beneficiário de arcar com o custo do medicamento prescrito;

3. comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;

4. negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;

5. impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

6. comprovação, à luz da **medicina baseada em evidências**, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por **evidências científicas de alto nível**, ou seja, **unicamente ensaios clínicos randomizados** e revisão sistemática ou meta-análise.

6.1. é da parte demandante o **ônus** de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, pois **não basta a simples alegação de necessidade do medicamento**, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

7. ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação.

7.1. na análise do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa é **vedado** ao Juiz substituir a vontade do administrador, **podendo tão somente** verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na CRFB, na legislação de regência e na política pública no SUS;

7.2. a análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado **restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação** e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, **não sendo possível incursão no mérito administrativo**.

Ademais, em se tratando de medicamento para uso *off label* (aquele em que o medicamento é utilizado no tratamento de patologias não autorizado pela agência governamental), mostra-se necessário observar o que fora decidido no pelo STJ no REsp 1657156/RJ, em que se concluiu pela possibilidade de compelir o Estado a fornecer medicamentos nessa condição, desde que tais medicamentos tenham sido previamente registrados na ANVISA e que o seu uso *off label* tenha sido autorizado pela referida agência.

Pois bem.

Como se pode notar, o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (e-NatJus) esclareceu o seguinte:

"[...].

Tipo da Tecnologia: Medicamento

Registro na ANVISA? Sim

Situação do registro: Válido

Nome comercial: -

Princípio Ativo: OMALIZUMABE

Via de administração: SC

Posologia: Conforme prescrição 300mg 1x/m

Uso contínuo? –

Duração do tratamento: (Indeterminado)

Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim

Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde para a situação clínica do demandante? Não

O medicamento está inserido no SUS? Sim O medicamento está incluído em: RENAME Oncológico? Não

[...].

Omalizumabe está disponível no SUS conforme para patologia/CID diverso.

[...].

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de urticária crônica espontânea grave, conforme relatório médico acostado nos autos

CONSIDERANDO que o paciente fez uso de anti-histamínicos em dose otimizada (cetirizina 40mg/dia).

CONSIDERANDO a evidência científica mais recente, em estudos clínicos independentes.

CONSIDERANDO que o Omalizumabe constitui terceira linha de tratamento para a UCE, segundo consenso da Sociedade Brasileira de Dermatologia para o tratamento da UCE, publicado em 2018, e é indicado se o paciente é refratário a dose otimizada (quadriplicada) de anti-histamínicos

CONCLUI-SE que HÁ ELEMENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES para sustentar a indicação de Omalizumabe para o caso em tela. Configura urgência conforme CFM, devido o quadro de angioedema.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa: Com risco potencial de vida

[...]."

Assim, no caso em apreço, (1) o medicamento está registrado na ANVISA; (2) foi comprovada a incapacidade financeira de WESLLAYNE MENDES FREIRE em arcar com o custo do medicamento. Não há provas nos autos que seja capaz de afastar a presunção de incapacidade; (3) foi juntado laudo médico fundamentado apontando a imprescindibilidade clínica do tratamento e descrevendo o tratamento já realizado; (4) a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa está comprovada; (5) o NatJus, por sua vez, apresentou Nota Técnica atestando a imprescindibilidade de uso do medicamento por WESLLAYNE MENDES FREIRE e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (6) o NatJus atestou a existência de provas técnico-científicas que embasem a utilização do medicamento solicitado no tratamento de WESLLAYNE MENDES FREIRE; (7) segundo o NatJus, não existe avaliação da CONITEC quanto ao medicamento pleiteado. Verifica-se, ainda, que a Nota Técnica apresenta elementos concretos e com base científica no sentido de que *"Em um ensaio clínico de fase III, Kaplan e colaboradores demonstraram que o omalizumabe foi superior ao placebo no tratamento de pacientes com UCE que não haviam respondido ao tratamento padrão com anti-histamínicos, sem diferenças significativas na taxa de efeitos colaterais entre os grupos tratados e controle"*. Desse modo, não se justifica que a até a presente data o fármaco não tenha sido inserido nas políticas públicas do SUS para o tratamento da enfermidade que afeta WESLLAYNE MENDES FREIRE.

Cabe registrar, também, que apesar do incontestável dever de o ente público fornecer o insumo pleiteado, essa obrigação **não pode ser perpétua**. Em geral, a enfermidade acometida aos pacientes é tratada com medicamentos e a evolução das drogas e procedimentos médicos evasivos ou não, podem no futuro próximo culminar com a cura, isto é, o pleno restabelecimento daquele. Da mesma forma, em se tratamento de fornecimento de medicamento, pode acontecer de não ser mais necessário a partir de determinado momento da vida da paciente.

Por isso, permite-se ao requerido, por meio do órgão competente, **analisar periodicamente** a eventual melhora e/ou total restabelecimento da WESLLAYNE MENDES FREIRE e/ou desnecessidade de fornecimento do bem de vida pleiteado, que **perdurará até que haja expressa recomendação médica em**

sentido contrário, devendo a WESLLAYNE MENDES FREIRE, nos termos do Enunciado nº 2, da 1ª Jornada de Saúde Pública do Conselho Nacional de Justiça[4] (file:///D:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/Por%20mat%C3%A9ria/Fazenda%20P%C3%BAblica/Sa%C3%BAde/Senten%C3%A7a/Proced%C3%AAnci **apresentar ao órgão competente indicado pelo ente público demandado receita médica a cada três meses**, para continuidade do fornecimento do produto em testilha.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da demanda para **JULGAR PROCEDENTE** o pedido formulado na petição inicial para **CONDENAR** o ESTADO DE PERNAMBUCO a fornecer a WESLLAYNE MENDES FREIRE, **no prazo de 30 (trinta dias)**, caso já não esteja fornecendo, o medicamento "OMALIZUMABE", **na forma e tempo receitado**.

Com fundamento na Súmula Vinculante nº 61, expeça-se **OFÍCIO** à CONITEC ou qualquer outro órgão competente posteriormente indicado, para avaliar a possibilidade de incorporação do medicamento no âmbito do SUS para o tratamento de **"Urticária Crônica Espontânea"**.

Em conformidade com o item "3.2." da tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral do STF e Súmula Vinculante n° 60, estabeleço que o **valor de venda** do medicamento deverá ser limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), **ou** valor já praticado pelo ente em compra pública, **aquele que seja identificado como menor valor**, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Em **nenhuma hipótese**, poderá haver pagamento judicial em **valor superior ao teto do PMVG**, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.

Nos termos do Enunciado nº 2, das Jornadas de Saúde Pública do Conselho Nacional de Justiça, deverá a WESLLAYNE MENDES FREIRE apresentar relatório/atestado médico atualizado indicado a necessidade de fornecimento do produto **a cada 03 (três) meses**, a contar da data de hoje, sob pena de perda de eficácia da medida, que será, eventualmente, declarada por este Juízo.

Isento o Estado de Pernambuco das custas processuais. Sem condenação em honorários, pois incabíveis em ação movida pelo Ministério Público.

Na forma do art. 496 do CPC, Súmula n° 490[5] (file:///D:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/Por%20mat%C3%A9ria/Fazenda%20P%C3%BAblica/Sa%C3%BAde/Senten%C3%A7a/Proced%C3%AAnci do STJ e REsp 1101727/PR[6] (file:///D:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/Por%20mat%C3%A9ria/Fazenda%20P%C3%BAblica/Sa%C3%BAde/Senten%C3%A7a/Proced%C3%AAnci (recurso repetitivo), tratando-se de sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, aguarde-se prazo para interposição de recurso voluntário e **REMETAM-SE** os autos em seguida ao Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Intimem-se.

Em sendo interposto recurso de **APELAÇÃO**, por não haver mais o juízo de prelibação nesta Instância (art. 1.010 do Código de Processo Civil), sem necessidade de nova conclusão, nos termos do art. 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, **INTIME-SE** o(a) apelado(a) para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997 do CPC), **INTIME-SE** a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC.

Caso sejam apresentadas contrarrazões, em sendo suscitadas preliminares, **INTIME-SE** o apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.009, § 2º, do Código de Processo Civil, manifeste-se acerca das referidas questões.

Após o prazo, com ou sem resposta, *ex vi* do disposto no § 3º do art. 1.010 do CPC, **REMETAM-SE** os autos ao E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, independentemente do juízo de admissibilidade.

Depois de cumpridas todas as disposições contidas nesta sentença, sem novos requerimentos, **arquive-se**.

Serra Talhada/PE, data conforme registro da assinatura eletrônica.

Diógenes Portela Saboia Soares Torres
Juiz de Direito

[1] (file:///D:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/Por%20mat%C3%A9ria/Fazenda%20P%C3%BAblica/Sa%C3%BAde/Senten%C3%A7a/Proced%C3%AAnci
Voto condutor nos autos do RE 195.192-3/RS - Segunda Turma do STF - julgado em 22/02/00.

[2] (file:///D:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/Por%20mat%C3%A9ria/Fazenda%20P%C3%BAblica/Sa%C3%BAde/Senten%C3%A7a/Proced%C3%AAnci
Curso de Direito Constitucional Positivo, 11. ed. - São Paulo: Malheiros Editores, 1996, p. 762.

[3] (file:///D:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/Por%20mat%C3%A9ria/Fazenda%20P%C3%BAblica/Sa%C3%BAde/Senten%C3%A7a/Proced%C3%AAnci
STF, 2ª Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 271.286/RS, Relator Ministro Celso de Mello, j. 12.09.2000, DJ 24.11.2000, p. 101.

[4] (file:///D:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/Por%20mat%C3%A9ria/Fazenda%20P%C3%BAblica/Sa%C3%BAde/Senten%C3%A7a/Proced%C3%AAnci
ENUNCIADO Nº 2: Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida.

[5] (file:///D:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/Por%20mat%C3%A9ria/Fazenda%20P%C3%BAblica/Sa%C3%BAde/Senten%C3%A7a/Proced%C3%AAnci
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”

[6] (file:///D:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/Por%20mat%C3%A9ria/Fazenda%20P%C3%BAblica/Sa%C3%BAde/Senten%C3%A7a/Proced%C3%AAnci
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CABIMENTO. 1. É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2º). 2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.” (STJ, REsp 1101727/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2009, DJe 03/12/2009)

Assinado eletronicamente por: DIOGENES PORTELA SABOIA SOARES TORRES
31/03/2025 15:09:47
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 199536536

25033115094769300000194417594

IMPRIMIR GERAR PDF